අංක ඊ 9 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිස් සේවා නියුක්තයන්ගේ සෞඛ්‍යය හා ඔවුන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම

I වැනි කොටස—බෝවෙන රෝග

1. **පාලන රෙගුලාසි—306, 307 යන වගන්ති.** යම් නිලධාරියෙකු වසඟ ගෙඩි බෝවෙන රෝගයකින් පෙළෙන්නෙක් සිටි නම් එම නිලධාරියා වහා ම තමන් සේවය කරන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානයාට ඒ බව දැනුම් දිය යුතු ය. මෙම රෝග නම් :—

'ඒ' ගණය—(1) වසූරිය, (2) මහාමාරිය, (3) කොලරාව, (4) ටයිපස් උණ, (5) කහ උණ.

'බී' ගණය—(1) පැපොල, (2) සරම්ප, (3) කම්මුල්ගාය, (4) ජර්මන් සරම්ප (රුබෙලාව), (5) කක්කල් කැස්ස, (6) තීව්‍ර පූර්වසඤ්ඤා පෝලියෝමයිලයිටිස්, (7) තීව්‍ර හෙවත් විසූචික පාවනය, (8) මස්තිෂ්ක කණ්ටක උණ, (9) අතීසාරය, (10) පුප්ඵුසීය ට්‍රයුබ්ක්ලෝසියාව, (11) සාමාන්‍ය හත්දෑ උණ, (12) ට්‍රෙපනසෝමියාව, (13) ටයිපොයිඩ් හෝ ආන්ත්‍රික උණ සහ (14) ඩිප්තිරියාව.

පවුලේ හෝ ගෙදර කෙනකුට බෝවෙන රෝගයක් වැළඳී විට සෑම නිලධාරියකුම රෝගය පැතිරීමේ අනතුරකට ඉඩ නොතබා සඛනිය රාජකාරි කටයුතුවල යෙදිය හැකි පරිදි රෝගය වැළඳී අයගෙන් වෙන්ව සිටිය යුතුය. තමා රෝගය වැළඳී අයගෙන් වෙන්ව වසන බවට සහතිකයක් ඔහු දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයාට දිය යුතු ය. එසේ කිරීමට නුපුළුවන් නම්—

(ඒ) තමාගෙන් රෝගය බෝවීමේ අනතුරක් නැති බවට හෝ

(බී) තමා කාර්යාලයට නැවිත් සිටිය යුතු කාලය සඳහන් කොට

ළඟම සිටින සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් හෝ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් ලබා ගත් සහතිකයක් ඔහු විසින් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම නිලධාරියා මෙහි ඉහත සඳහන් රෙගුලාසියේ ඒ ගණය යටතේ දක්වෙන රෝගයක් ස්පර්ශ වූවෙක් නම් මේ සඳහා අවශ්‍ය නිවාඩු සම්පූර්ණ පඩි සහිත ව දුන් විශේෂ නිවාඩු හැටියට ගැණෙනු ඇත.

2. **නිවාරණ හා මර්දන උපක්‍රම—ටයිපොයිඩ් හෝ ආන්ත්‍රික උණ.** සේවයට බඳවා ගැනීමේ දී සෑම පොලිස් නිලධාරියකුට ම ආන්ත්‍රික උණ වැළැක්වීම සඳහා බෙහෙත් විදිනු ලැබේ. සේවා ලේඛනයේ "සෞඛ්‍ය ඉතිහාසය" යන ශීර්ෂය යටතේ බෙහෙත් විද්ද දිනය රතු තීන්තෙන් සටහන් කළ යුතු ය. ඊට පසුව අවුරුදු පතා ඔවුන්ට නැවත බෙහෙත් විද එසේ නැවත විද්ද දිනය සේවා ලේඛනයේ රතු තීන්තෙන් සටහන් කළ යුතු ය.

පොලිස් ස්ථානවල සියලු ම කාර්ය භාර නිලධාරීන් තමන් යටතේ සේවය කරන සෑම පොලිස් නිලධාරියකු ම බෙහෙත් විද්දවා ගත් දින සටහන් කළ ලේඛනයක් පිළියෙලකොට තබා ගත යුතු ය. පොලිස් නිලධාරීන්ට නොවරදවා බෙහෙත් විද්දවා ගන්නට සලස්වනු සඳහා පරීක්ෂක නිලධාරීන් මෙම ලේඛනය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු ය.

ගැසට් කළ නිලධාරීන් බෙහෙත් විද්දවා ගත් දින සටහන් කළ ලේඛනයක් පොලිස් මූලස්ථානයේ තබා ගත යුතු ය.

කොළඹ නම් පොලිස් වෛද්‍යවරයා ද පිට පළාත්වල නම් ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධාරියා ද මුදල් අය කිරීමක් නැති ව බෙහෙත් විදිනු ඇත.

මර්දන උපක්‍රම

(i) උණු කොට නිවාගත් ජලය බීමට ගන්න.

(ii) අවට ප්‍රදේශය මැස්සන් බෝ වීමට ඉඩ නොතබා පිරිසිදු ව තබා ගන්න.

(iii) වැසිකිළියට ගොස් පැමිණි විට සබන් ගා අත් සෝදා ගන්න. අත්වල නියපොතු කොටකර කපන්න.

පොලිස් සේවයේ කෙනකුට ටයිපොයිඩ් හෝ ආන්ත්‍රික උණ වැළඳී ඇතැයි සථිර වශයෙන් තීරණය වූ විට—වෛද්‍යවරයාගේ රෝග විනිශ්චය දැනගත් වහා ම—පළාත්බද හෝ ප්‍රාදේශික මූලස්ථානය මගින් පොලිස් මූලස්ථානයට වාර්තාකර සිටිය යුතු ය.

පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම වාර්තාවලට ඇතුළත් විය යුතු ය :-

(i) ආන්ත්‍රික උණ බෝවූයේ කෙසේ ද ?

(ii) රෝගියා වාසය කළේ කොහිද ?

(iii) ඔහු කෑම කෑවේ කොහිද ?

(iv) ඔහු බීමට ගත් වතුර මොනවා ද ?

(v) අවට මහජනයා අතරත් රෝගීන් ගැන වාර්තා වී තිබේ ද?

(vi) රෝගයේ මූලාශ්‍රය සොයන්නට වෛද්‍ය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂක නිලධාරීන් කුමක් කර තිබේ ද? ප්‍රතිඵල කවරේ ද?

(vii) ඔහුට අන්තිමට බෙහෙත් මිද ඇත්තේ කවදා ද?

3. **බරවා රෝගය.** හලාවත සිට තංගල්ල දක්වා වෙරළබඩ තීරය දිගේ මූදුකරයේ සිට දළ වශයෙන් සැතැප්මක් පමණ පළලට, බෙහෙවින් ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල මෙම රෝගය පවතී.

මර්දන උපක්‍රම. මෙම වෙරළබඩ තීරයේ පදිංචි අය, ප්‍රාදේශික සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් පරිදි ලේ පරීක්ෂා කරවා ගත යුතු ය. යම්කුට බරවා රෝගය වැළඳීමට ඉඩ ඇති බව ලේ පරීක්ෂාවෙන් පෙනී ගියහොත් ඔහු ප්‍රාදේශික සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නියම කරන පරිදි ප්‍රතිකාර ගත යුතු ය.

මෙම වෙරළබඩ තීරයේ වාසය කරන අය මදුරු දැල් පාවිච්චි කිරීම හොඳ ය.

අවට ඇති වළවල්, වැසි දිය එකතු වන භාජන, වැසිකිළි අසල දියවළවල් ආදියෙහි මදුරුවන් බෝ වීමට ඉඩ නොදිය යුතු ය. අපිරිසිදු ජලයේ මේ මදුරුවන් බෝ වන හෙයින් වාසස්ථාන අසල කුණු වතුර එකතු වන්නට කිසි විටෙකත් ඉඩ නොතැබිය යුතු ය.

4. **වසූරිය.** සේවයට බඳවා ගත් විට සෑම පොලිස් නිලධාරියකුම වසූරියෙන් මිදෙනු සඳහා එන්නත් කරවා ගත යුතුය. සේවා ලේඛනයේ "සෞඛ්‍ය ඉතිහාසය" යන ශීර්ෂය යටතේ, එන්නත් කළ දිනය සඳහන් සටහනක් රතු තීන්තෙන් ලිඛිය යුතු ය.

අවුරුදු 5ක් පාසා ඔවුන් නැවත එන්නත් කරවා ගත යුතු අතර, එසේ නැවත එන්නත් කළ දිනය සඳහන්කොට සේවා ලේඛනයෙහි සටහනක් ලිඛිය යුතු ය.

වසූරි රෝගය පැතිර යන අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධ රාජකාරි වැඩවල යෙදෙන්නට පළමු සෑම පොලිස් නිලධාරියකු ම, කලින් එන්නත් කළ දිනය කුමක් වුවත්, විශේෂ ආරක්ෂාව සඳහා නැවත එන්නත් කරවා ගත යුතු ය.

රටට හොරෙන් පැමිණෙන්නවුන් වෙන්කොට තබන කඳවුරුවල රැකවලට නිලකොට සිටින පොලිස් නිලධාරීන් අවුරුද්දකට වරක් එන්නත් කරවා ගත යුතු ය.

5. **ක්ෂය රෝගය (වියුබ්කුලෝසිසාව).** සෑම පොලිස් නිලධාරියකු ම සේවයට බඳවා ගැනීමට පළමු ආණ්ඩුවේ ක්ෂය රෝග නිලධාරියකු විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබිය යුතු ය. මෙම පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් විය යුතු ය:—

(i) වියුබ්කුලීය මැන්ටු පරීක්ෂණය.

(ii) (සෘණ ලක්ෂණ ඇති හෙවත්) ප්‍රතිශක්තිය නැති අයට බී.සී.ජී. එන්නත් කිරීම.

(iii) 'ඇක්සේ්' පරීක්ෂණය.

සේවයේ සිටින පොලිස් නිලධාරීන් ද—

(ඒ) අවුරුදු 3කට වරක් වියුබ්කුලීය පරීක්ෂණයක් කරවා ගත යුතු ය.

(බී) වියුබ්කුලීය සෘණ ලක්ෂණ ඇති රෝගීන් බී.සී.ජී. එන්නත් කරවා ගත යුතු ය.

(සී) බී.සී.ජී. එන්නත් කරනු ලැබූ පසු එසේ එන්නත් කළ දින සිට දෙමසක් ගතවූ නැන ඔවුන් නැවත පරීක්ෂණයකට භාජන විය යුතු ය.

(ඩී) අවුරුද්දකට වරක් වත් 'ඇක්ස්රේ' කරවා ගත යුතු ය.

(ඊ) පහත සඳහන් සලකුණු හා රෝග ලක්ෂණ එකක් හෝ වැඩි ගණනක් දක්නට ඇත්නම් පරීක්ෂා කරවා ගත යුතු ය. එනම්—

(1) නියම හේතුවක් නැතිව හැන්දෑවට උණ ගැනීම,

(2) රෑට දහඩිය ගැලීම,

(3) ක්‍රමයෙන් බර අඩු වීම,

(4) ආහාර අරුචිය,

(5) වියළි කැස්ස නැතහොත් කල් පවතින කැස්ස හෝ ප්‍රතිශ්‍යාව,

(6) මිරිකින් විට හෝ දිගට ම පපුවේ කැක්කුම,

(7) කළ වැඩවල තරමට වැඩියෙන් වෙහෙස දැනීම,

(8) කැස්ස හෝ කෙළ සමග ලේ යෑම,

(9) දිගින් දිගට ම පවත්නා අජීරණය.

පරීක්ෂා කරවා ගැනීමටත්, ප්‍රතිකාර ගැනීමට හා උපදෙස් ලබා ගැනීමටත් කොළඹ ප්‍රධාන පෙනහැලි චිකිත්සාගාරයේත් පිට පළාත්වල සියලු ම පෙනහැලි ආරෝග්‍යශාලාවල හා චිකිත්සාගාර වලත් පහසුකම් තිබේ.

ක්ෂය රෝගය සුව කළ හැකි වූත් වැළැක්විය හැකි වූත් රෝගයකි. එහෙත් එම රෝගය මර්දනය කිරීමට හෝ වැළැක්වීමට සෑම කෙනෙකුගේ ම සහයෝගය අවශ්‍ය ය. පහත සඳහන් සුළු කරුණු පුරුදු කර ගතහොත් රෝගය පැතිර යෑම වැළැක්වීමට එය මහෝපකාරී වනු ඇත :—

(i) පිලේත් විදිවලත් ඝිය ඝිය තැන කෙළ නොගැසිය යුතු ය.

(ii) කහින විට හෝ කිවිසින විට නිතර ම ලේන්සුවකින් මුහුණ කට වසා ගත යුතු ය.

(iii) අත්වල විෂබීජ රැඳෙන්නට ඉඩ නොදිය යුතු ය. නිතර ම ආහාර ගැනීමට පළමු සබන් හා අත් සෝදා ගත යුතු ය.

(iv) ඔබ නිදන කාමරයට පිරිසිදු වාතාශ්‍රය ලැබෙන සේ ජනේල ඇර තබා නිදා ගත යුතු ය.

(v) ඔබේ කාමරවල තද බදව සිවිමෙන් වැළකිය යුතු ය.

(vi) හිරු එළියෙන් විෂබීජ නැසෙන හෙයින් ඔබේ නිල ඇඳුම් හා අනිකුත් ඇඳුම් පැළඳුම් අවුවේ දැමිය යුතු ය.

6. **කෘම රෝග.** පහත සඳහන් රෝග කෘම රෝග ගණයට ඇතුළත් වේ.

(i) උපදංශය,

(ii) ගොනොරියාව,

(iii) රති වුණ,

(iv) ලසිකා කණාර්බුද කාමරෝගය,

(v) වංක්ෂණ කණාර්බුදය,

(vi) අප්‍රමේහාණුක මූත්‍රමාර්ග ක්ෝපය.

මේ. රෝගවලින් වැඩි හරියක් ම කෙනකුගෙන් තවත් කෙනකුට බෝ වන්නේ කාම සම්භෝගයෙනි. මෙම රෝගය වැළඳුණහු ජන සමාජයට රෝගය බෝ කරන්නෝ වෙති.

මෙම රෝග වැළැක්වීමේ එක ම නොවරදින ක්‍රමය නම් විවාහක භාර්යාව හෝ සවාමිපුරුෂයා හැර අන් කෙනකු සමග සම්බන්ධකම් ඇතිකර ගැනීමෙන් වැළකීමයි.

රෝගය බෝවීමට ඉඩ ඇති අන්දමින් තමා හැසිරුණු බව හේතු සහිත ව යම් තැනැත්තකුට විශ්වාස කළ හැකි නම් ඔහු පූර්ණකාල කාමරෝග චිකිත්සාගාරයක හෝ ආයතනයක වෛද්‍ය නිලධාරියා වෙත ගොස් එම වෛද්‍ය නිලධාරියාගේ උපදෙස් අනුව ඔහු දෙන බෙහෙත් පාවිච්චි කළ යුතු ය.

7. **රහසය** (පිස්සු බලු රෝගය). පිස්සු බලු විෂක් ස්පර්ශ වූ සෑම කෙනකු ම වැක්කෙරෙන ජලයකින් එම තුවාල සබන් දමා සෝදා කොන්ඩිස්, අයිඩින් ආදී තුවාල සැරහුමක් ලෑමෙන් ප්‍රථමාධාර ප්‍රතිකාර කරවා ගත යුතු ය. ඉන් පසු වහා ම ආරෝග්‍යශාලාවකට ගොස් පිස්සු බලු විෂ නාශක ප්‍රතිකාර ක්‍රමය අඩු නැතිව ලබා ගන්නා ලෙස ඔවුන්ට උපදෙස් දිය යුතු ය.

ප්‍රතිරහස පාස්චර් ප්‍රතිකාර ක්‍රමය මෙහි පහත සඳහන් අයට අප්‍රමාදව ලබා දිය යුතු ය:—

(i) රහසය වැළදි බල්ලකු විසින් හෝ වෙනත් සතකු විසින් සපනු ලැබූ හෝ සූරනු ලැබූ අය.

(ii) රහසය වැළදි සතකු විසින් ලෙවකන ලද (කැපුම්, සිරිම්, වණ ආදී) තුවාල ඇති අය.

(iii) සොයා ගන්නට නැති දඬුවතේ යන බල්ලන් හෝ වෙනත් සතුන් විසින් සපයනු ලැබූ අය.

(iv) සපන වේලාවේ සතාගේ තත්ත්වය කුමක් වුවත්, මුහුණ, හිස යන මේ තැන් සපනු ලැබූ, නැතහොත් ඉරුණු තුවාල ඇති හෝ බොහෝ තැන් තුවාල වූ අය.

(v) රහසය වැළදී ඇතැයි සැක කළ, එහෙත් එතෙක් නොමැරී සිටින සතුන් විසින් සපනු ලැබූ අය. දින 7—10ක් සේදිසියෙන් සිට එම සතා නොමැරී හොඳින් සිටියොත් මෙහි (iv) වැනි (v) වැනි ගණවල අයට ප්‍රතිකාර නතර කළ හැකි ය. හැකි සෑම විටක ම මේ කාලය තුළ සතා නොමරා සේදිසියට භාජනකොට තබාගත යුතු ය.

(vi) සතකු විසින් සපා කනු ලැබ දින 7—10 දක්වා කාලයක් ගත වන්නට පළමු සතා මැරී ඌට වැළදී තිබූ රෝගය විනිශ්චය කර නැති අවසථාවල, එම සතා විසින් සපනු ලැබූ අය. එවැනි අවසථාවල සතාගේ හිස පරීක්ෂණය සඳහා යවා ඇතොත් රෝගීන් එම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල බලා නොසිට වහා ම ප්‍රතිකාර ගැනීම ආරම්භ කළ යුතු ය.

(vii) මුලින් ම රෝග ලක්‍ෂණ ඇති වන්නට දින 4කට පමණ කලින් සිට රහසය වැළඳී සතකුගේ කෙළවලින් රෝගය බෝවිය හැකි හෙයින් මේ කාල සීමාව තුළ එම සතුන් විසින් සපා කනු ලැබූ, නැතහොත් එම සතුන් අතපත ගා ඇති සෑම කෙනෙකුට ම රෝගය බෝවීමට ඉඩ තිබේ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කළ යුතු ය. සාමාන්‍යයෙන් දෙන ඉන්ජැක්ෂන් 14 නියම කර ඇත්තේ ශරීරයේ වෙනත් කොටස්වල සීරීම් ආදී වූ මතුපිට තුවාල ඇති විටත් නොමේඵණු තුවාල තිබී ඒවා ලෙවකා ඇති විටත් දීමට ය.

වැනි කොටස—පොලිස් නිලධාරින්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයටත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීම

පොලිස් සේවයේ සෑම කෙනකුට ම ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය ආයතනවලින් නොමිලයේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබිය හැකි ය. ඔවුන් ආරෝග්‍යශාලාවට ඇතුල් වුවහොත් එසේ ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඒ ඒ පන්තිවල වාට්ටු ලැබෙන්නේ මෙසේ ය:—

(i) රු. 5,580 ට වැඩි වාර්ෂික වැටුපක් ලබන නිලධාරින්ට— 1 වැනි පන්තියේ වාට්ටු.

(ii) වෂියකට රු. 744 කට අඩු ආරම්භක වැටුපක් හිමි ශ්‍රේණිවලට අයත් නිලධාරින් හැර රු. 5,580 කට නොවැඩි වාර්ෂික වැටුපක් ලබන නිලධාරින්ට—2 වැනි පන්තියේ වාට්ටු.

7. මේ සහනය ලැබෙන්නේ පොලිස් සේවයේ නියුක්ත අයට පමණකි; ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයට නොවේ.

8. පොලිස් සේවයේ සියලු ම නිලධාරීන්ට, කොළඹ පදිංචි ව සිටිනොත් පොලිස් වෛද්‍යවරයා ගෙන් ද පිට පළාත්වල පදිංචි ව සිටිනොත් ළඟ ම වෛද්‍ය නිලධාරියාගෙන් ද තමන්ටත් තම පවුලේ අයටත් තමාගේ නිවසේදී ම නොමිලයේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගත හැකි ය.

9. ආරෝග්‍යශාලාවක නැවතී ප්‍රතිකාර ලැබිය යුතු පොලිස් සේවයේ නියුක්ත අයගේ පවුල්වල අයට නම් මු. රෙ. 1758 වැන්නෙහි දක්වා ඇති ප්‍රකාර පහසු ක්‍රමයට ආරෝග්‍යශාලා ගාස්තු ගෙවීමේ සහනය ලැබීමට හිමිකම් ඇත්තේ ය. තමාට හෝ තම පවුලේ කෙනකුට ආණ්ඩුවේ ආරෝග්‍යශාලාවක නැවතී ප්‍රතිකාර ගනු කැමති පොලිස් නිලධාරියෙක් ඇත්නම් ඔහු තම තරාතිරම හා වැටුපත්, තමාට හිමි සහනයත් සඳහන් කොට, පළාතේ, කොට්ඨාසයේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාගෙන් හැඳින්වීමේ ලිපියක් ලබා ගත යුතු ය.

10. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය පිට පළාත්වල පොලිස් නිලධාරින්ට පළමුකොට ළඟ ම සිටින ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධාරියා හමු විය යුතු ය. වෛද්‍ය නිලධාරියා එම රෝගීන් ප්‍රාදේශික චිකිත්සාගාරයට ද, එහි දී සුදුසු ප්‍රතිකාර ලබා ගත නොහැකි නම් එම ප්‍රදේශයේ මූලික ආරෝග්‍ය ශාලාවට ද යවනු ඇත. එහෙත් යම් රෝගයක් ගැන කොළඹ දී පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය සේ සලකතොත්, එම ප්‍රතිකාර ලැබීම සඳහා රෝගියා කොළඹ පොලිස් වෛද්‍යවරයා වෙත යවනු ඇත.

III වැනි කොටස—පොලිස් නිලධාරින්ට දන්ත ප්‍රතිකාර

ලබන වැටුප කුමක් වුව ද, සෑම තරාතිරමක ම පොලිස් නිලධාරින්ට, දත් ඉගිල්ලීම්, පිරවීම් හා ඇඹිරීම් ඇතුළු සෑම ප්‍රතිකාරයක් ම කොළඹ දන්තාරෝග්‍යශාලාවෙන් හෝ පිට පළාත්වල ආණ්ඩුවේ ආරෝග්‍යශාලාවල දන්ත චිකිත්සාගාරවලින් හෝ නොමිලයේ ලබාගත හැකි ය.

2. එහෙත් බොරු දත් නොමිලයේ සපයනු ලබන්නේ ප්‍රධාන පරීක්ෂක තත්ත්වයේ හෝ ඊට පහළ නිලධාරින්ට පමණකි. බොරු දත් සපයනු ලබන්නේ කොළඹ දන්තාරෝග්‍යශාලාවෙන් පමණි.

3. මේ පිළිබඳ කාර්ය පිළිවෙල මෙසේ යි:—

(ඒ) **කොළඹ දී.**—දන්ත ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය පොලිස් නිලධාරියා පොලිස් වෛද්‍යවරයා වෙත හෝ තමාට වඩා ම ළඟ කොළඹ චිකිත්සාගාරයට හෝ යා යුතු ය.

(බී) **පිට පළාතක දී.**—දන්ත ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය පොලිස් නිලධාරියා, ඒ සඳහා, පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් ළඟ ම ඇති දන්ත චිකිත්සාගාරයට යැවිය යුතු ය. ප්‍රධාන පරීක්ෂක තත්ත්වයේ හෝ ඊට පහළ තරාතිරමක රෝගියකුට බොරු දත් අවශ්‍ය වූ විට ඔහු, තමා ප්‍රතිකාර ගන්නා චිකිත්සාගාරයෙන් වාර්තාවක් ලබා ගෙන පොලිස් වෛද්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. පොලිස් වෛද්‍යවරයා ඔහු බොරු දත් ලබා ගනු සඳහා කොළඹ දන්තාරෝග්‍යශාලාවට යැවීමට අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතු ය.

IV වැනි කොටස—ලේ වර්ග කිරීම

සෑම පොලිස් නිලධාරියකු ම බඳවා ගනු ලැබූ පසු අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ සිටිය දීම ලේ වර්ග කරනු සඳහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජන විය යුතු ය. පළාත්වල, දිස්ත්‍රික්කවල හා කොට්ඨාශවල සිටින එතෙක් ලේ වර්ග කරනු නොලැබූ නිලධාරීන්ගේ ද ලේ පරීක්ෂා කරවා වර්ග කරවීමට පළාතේ, කොට්ඨාශයේ, දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා ක්‍රියා කළ යුතු ය.

2. ලේ ගණය දැනගත් විගස ම (ඒ) නිලධාරියාගේ සේවා ලේඛනයේ "සෞඛ්‍ය ඉතිහාසය" යන ශීර්ෂය යටතේ ද, (බී) නම් ලැයිස්තු පත්‍රයේ "විවිධ තොරතුරු" තීරයේ ද කොටසක් ලිවිය යුතු ය.

3. පොලිස් ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් ඒ ඒ පොලිස් ස්ථානයට අයත් සියලු ම නිලධාරීන්ගේ නම් හා ඔවුන්ගේ ලේ ගණය පිළිබඳ විස්තර ද දැක්වෙන බිත්තියේ එල්ලන ලිපි ගොනුවක් තබා ගත යුතු ය. නිලධාරීන් පොලිස් ස්ථානයට මාරු කර එවන හෝ පොලිස් ස්ථානයේ සිට මාරුකර යවන පිළිවෙලින් මෙම ලැයිස්තුව අනුනව සම්පූර්ණකොට තබාගත යුතු ය.

4. ලේ දන්දීමට හෝ ලේ ප්‍රවේශනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට ඉහත කී විස්තර ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. ලේ දන්දීම සඳහා ලේ වර්ග කර ඇති අයුරු මෙසේ ය:—

"ඒ", "බී", "ඒබී" සහ "ඕ"—ගණය.

ලේ දන් දෙනු කැමැත්තන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවල පොලිස් ස්ථානවල ඇති බිත්ති ලේඛන බැලිය යුතු ය. පොලිස් සේවයේ කෙනකු ලේ දන් දුන් විට බිත්ති ලේඛනයේ සටහනක් ලිවිය යුතු ය. පළාත හෝ කොට්ඨාශය තුළ ලේ දන් දුන් සෑම අවස්ථාවක ම එය පාලන වාර්තාවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

V වැනි කොටස—බෝවෙන රෝග වැළදි අවස්ථාවල රෝගය ස්පර්ශ වූ පොලිස් සේවකයන් වෙන් කොට තැබීම

මහාමාරිය, කොළරාව හෝ වසූරිය ස්පර්ශ සිටින බැරුක්කවල පදිංචි පොලිස් නිලධාරීන් ඉදින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා දවසට දෙවරක් පෙරෙට්ටුවට එනොත් වෙන් කර තබන කඳවුරුවල රැඳවීම අවශ්‍ය නොවන බව පළාත්වල, දිස්ත්‍රික්කවල හෝ කොට්ඨාශවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් සලකා ගත යුතු ය. එහෙත් එම භටයන්ගේ භාර්යාව, පවුලේ අය ආදී වශයෙන් එවැනි විනයානුකූල පාලනයකට ඇතුළත් කළ නො හැකි අය නම්, වෙන් කර තබන කඳවුරුවලට මාරු කිරීම සුදුසුය යි වෛද්‍ය නිලධාරියාට අදහස් වෙතොත් එසේ යැවිය යුතු ය. (වර්ෂ 1933 ජනවාරි 25 වැනි දින අංක 5/ මඝි. ඒ දරන වෛ. හා සෞ. සේ. අධ්‍යක්ෂගේ චක්‍රලේඛය)

සේදිසියට යටත් ව සිටින කාලය තුළ පැය 12 කට වැඩි කාලයක් කිසි ම පොලිස් නිලධාරියකුට නිවාඩු නො දෙන හැටියටත් නැත හොත් කිසි ම යම් විශේෂ රාජකාරියකට පිටත් නොකරන හැටියටත් වග බලා ගැනීම, නිරීක්ෂණයට භාජන ව සිටින භටයන් භාර නිලධාරියා අයත් වගකීම වන්නේ ය.